EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Elemento	Descripción	
Código	05-03-1.1	
Nombre	Porcentaje de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro factor de riesgo cardiovascular, que se atienden en consulta modalidad grupal de Nutrición.	
Definición conceptual	El indicador mide la proporción de personas de 40 a 64 años con obesidad y otro Factor de Riesgo Cardiovascular (FRC) que asisten a la consulta modalidad grupal en las áreas de salud que cuentan con profesional en Nutrición según lo indica la normativa técnica vigente. La Coordinación Nacional de Nutrición ha definido que todas las personas con obesidad y otro FRC deben atenderse en consulta modalidad grupal (1). Incluye: • Atenciones de primera vez de la población de 40 a 64 años con un IMC ≥30,0 Kg/m^2 y otro FRC en el periodo. • Atenciones de las personas de 40 a 64 años con un IMC ≥30,0 kg/m^2, otro FRC y registro de participación en la consulta modalidad grupal de Nutrición en el periodo. • Otro FRC: ◦ Diabetes Mellitus: Código **E11**-Diabetes Mellitus tipo 2 ◦ Hipertensión: Código **I10X**-Hipertensión esencial (Primaria) ◦ Dislipidemia: Código **E78**-Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias. • Áreas de Salud con profesional en Nutrición. Excluye: • IMC con inconsistencias (≤10,0 y ≥105,0 kg/m^2 o ausencia de peso y/o talla). • Personas atendidas en consulta modalidad grupal de Nutrición en los cinco periodos anteriores a la evaluación, según normativa (2).	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 40 a 64 años con IMC ≥30,0 Kg/m^2, otro FRC y participación en consulta grupal de Nutrición en el periodo. • Número de personas atendidas de 40 a 64 años con IMC ≥30,0 Kg/m^2 y otro FRC en el periodo.	
Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 40 a 64 años con IMC ≥30,0 Kg/m}^2\text{, otro FRC y participación en consulta grupal de Nutrición en el periodo}}{\text{Número de personas atendidas de 40 a 64 años con IMC ≥30,0 Kg/m}^2\text{ y otro FRC en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	ECNT - Obesidad y Síndrome Metabólico

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Línea base	3 %
Meta	Quinquenal: 7 % (corresponde al percentil 75)
Periodicidad	Anual
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Generales): • Consultas de la población de 40 a 64 años. • Consultas modalidad grupales de Nutrición en periodo evaluado y previos. • Consultas de población de 40 a 64 años con diagnóstico de HT o DM tipo 2 o dislipidemia.
Clasificación	Indicador de proceso.
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Monitoreos y anual) • Informe de Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual)
Comentarios generales	Según el Plan de sensibilización e información en salud cardiovascular, enfermedades no transmisibles y obesidad, 2023, debe evidenciarse la incorporación de paciente con enfermedades crónicas al programa PINEC. (1) La modalidad de atención de las personas con obesidad referidas a nutrición queda definida en el documento Instrucción de trabajo para profesionales de Nutrición en el desarrollo de la consulta externa para personas con obesidad en los tres nivele de atención, CÓDIGO: IT.GM.DDSS, ARSDT.CNN.27092024. (2) No es necesario realizar una nueva referencia a Nutrición si ya existe el registro en EDUS de la atención en los últimos cinco años, según acuerdo de reunión tomado con los miembros de la comisión integrada por el Programa de Normalización de la APAEC, la Coordinación Nacional de Nutrición y la participación de la DCSS, lo cual quedará descrito en el documento denominado “Protocolo de Atención Clínica para el Abordaje Integral de la Persona Usuaria con Sobrepeso y Obesidad en la Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”, 2026.